

Amil Espaço Saúde Nova Iguaçu

Rua Athaíde Pimenta de Moares, 408

Centro, Nova Iguaçu - RJ

TESTE ERGOMÉTRICO

Exame ex07530 realizado em 22/07/2025

Esteira rolante - protocolo Rampa - 1,3 MET/min

Médico Responsável: Dr. BRENO NOGUEIRA DA ROSA

Paciente : GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

pc06832

Idade : 26 anos (01/03/1999)

Sexo : Masculino

Altura : 168 cm **Peso** : 69,0 kg **Índice de massa corporal** : 24,4

Probabilidade DAC (Morise): 3 (Probab. DAC: < 9 - Baixa Entre 9 e 15 - Média > 15 - Alta)

Solicitação feita por: Dr. PEDRO BRANDÃO C. LEITE

Nenhuma medicação em uso.

Indicações principais do teste

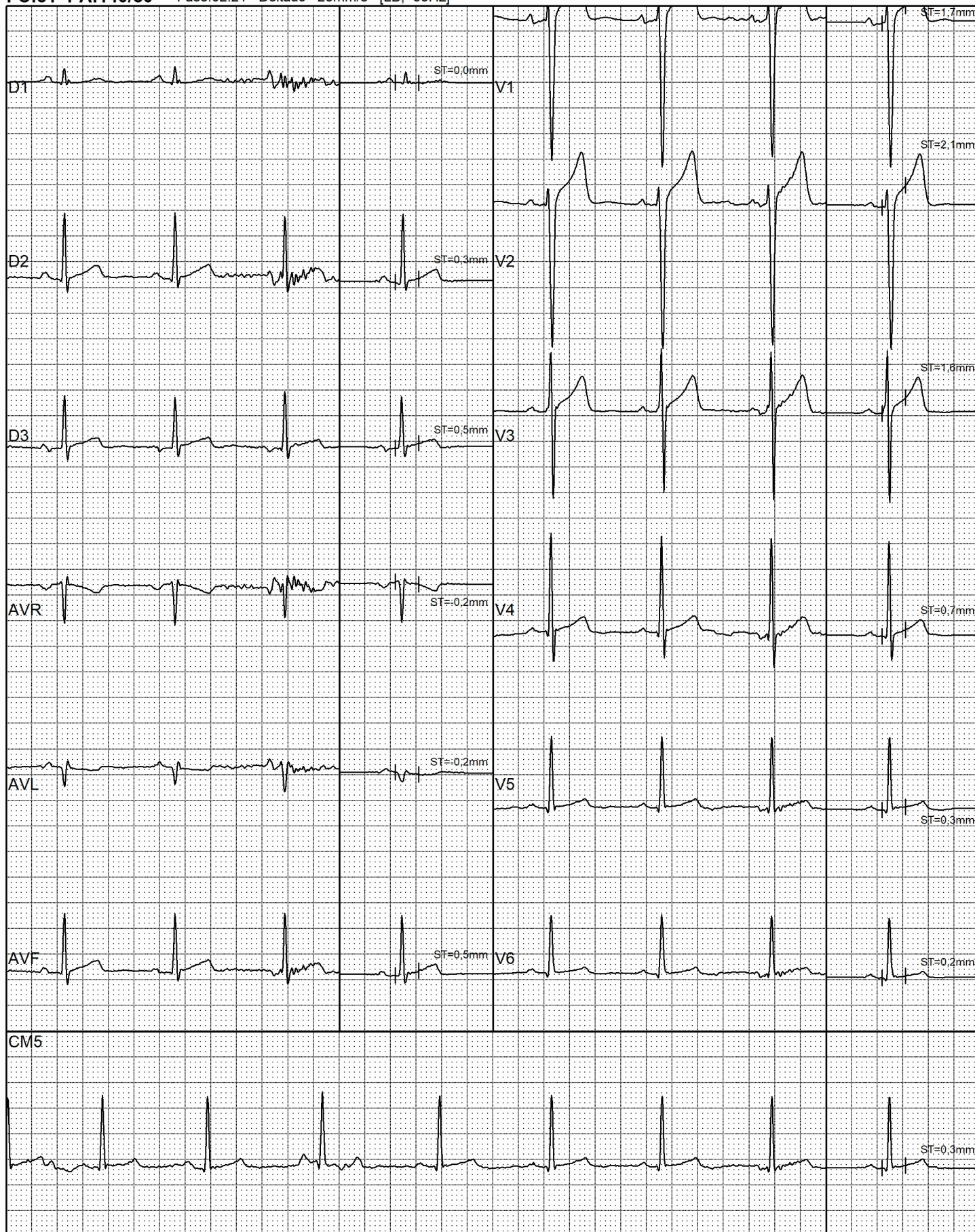
- Avaliação da capacidade funcional
- Avaliação da resposta pressórica
- Realização de Check-up

Fatores de risco coronariano

- Estresse

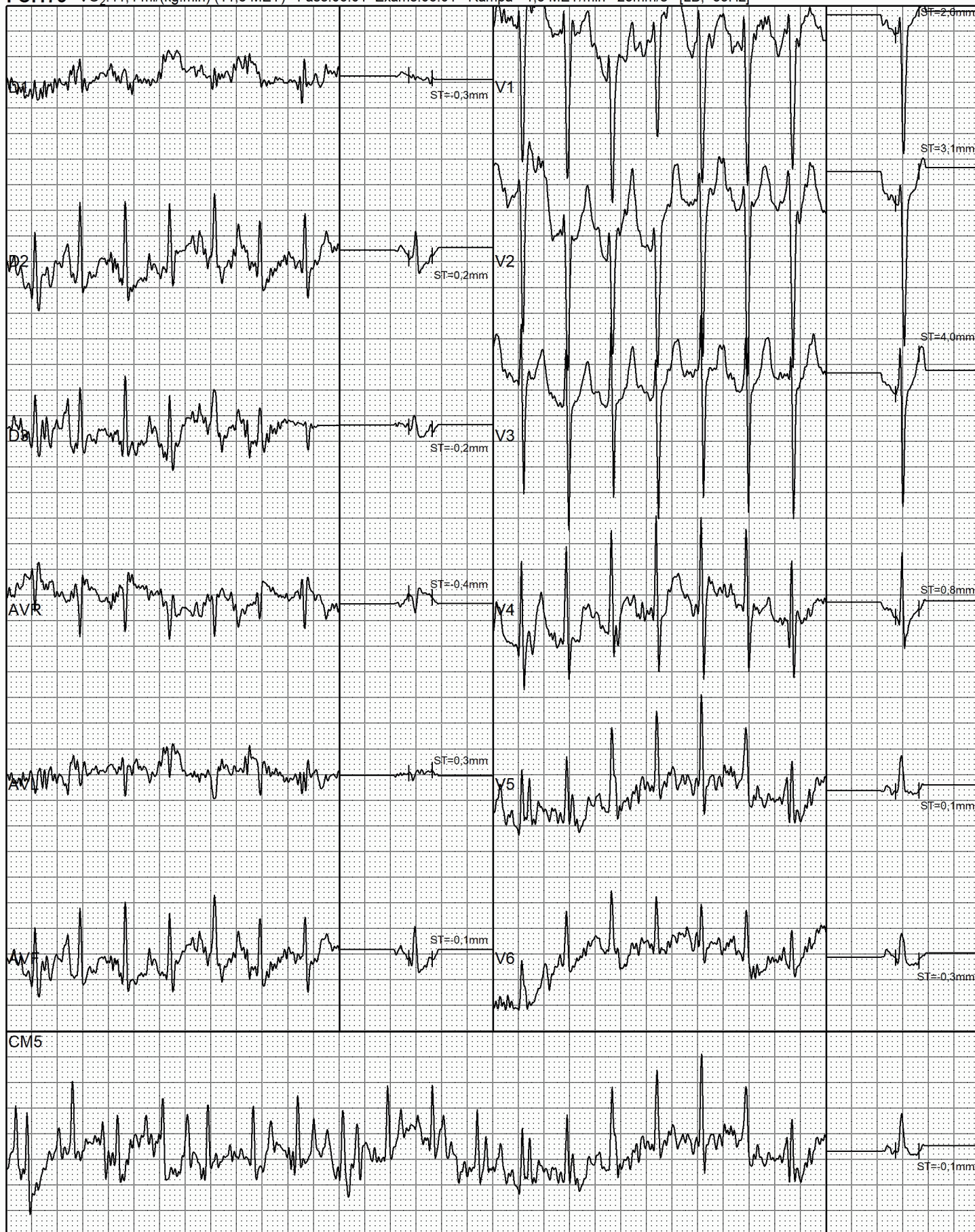
História clínica

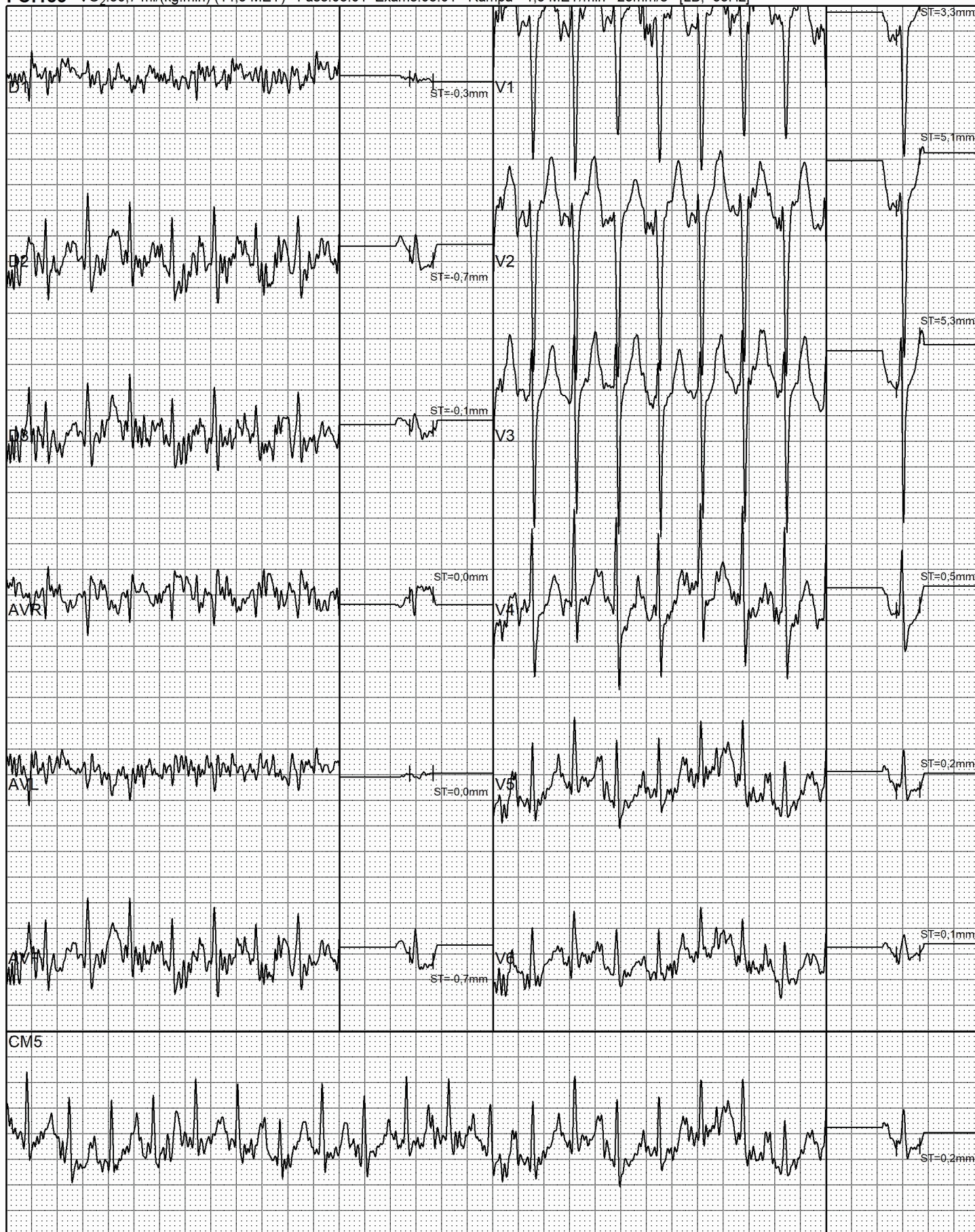
- Cefaléia

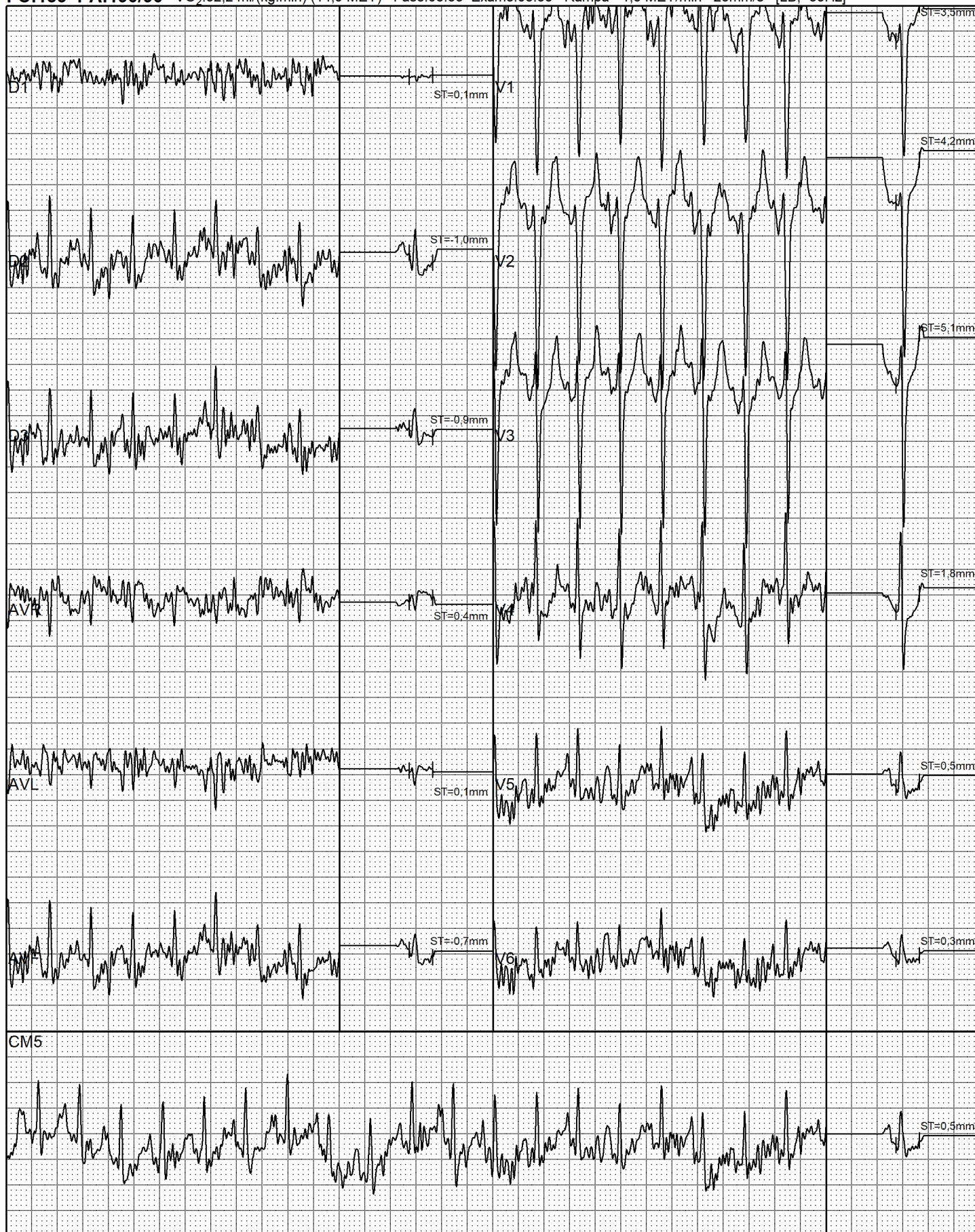


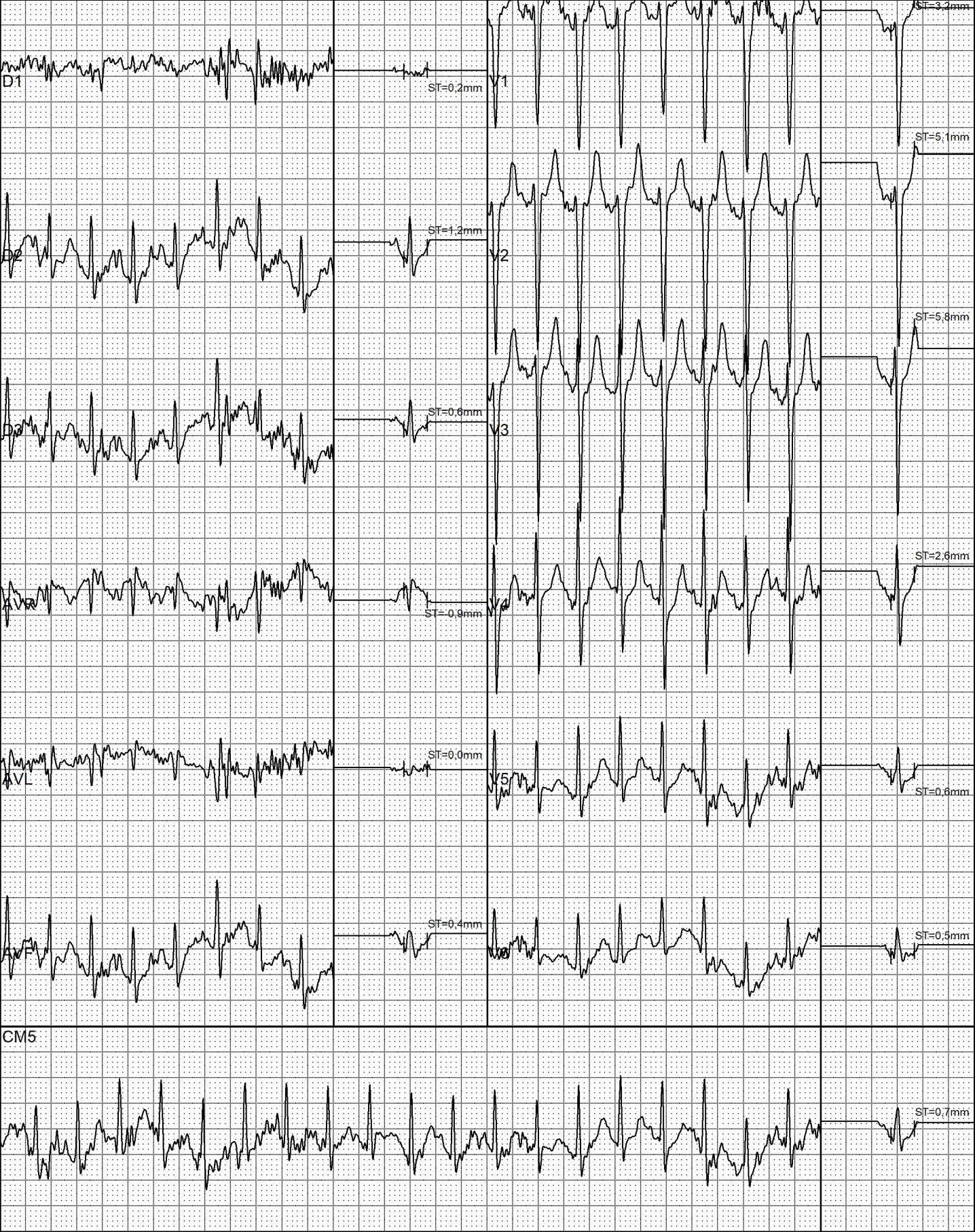


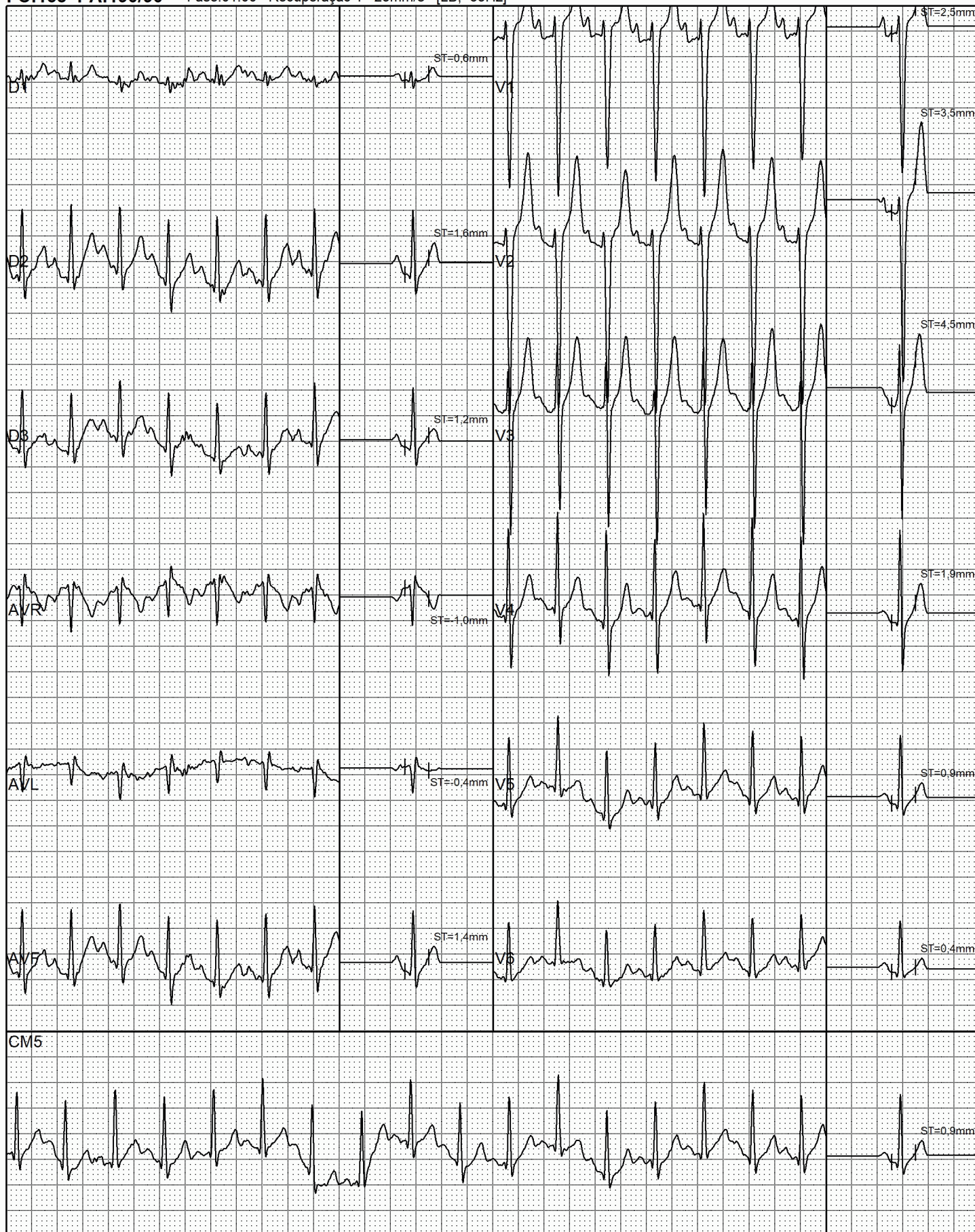


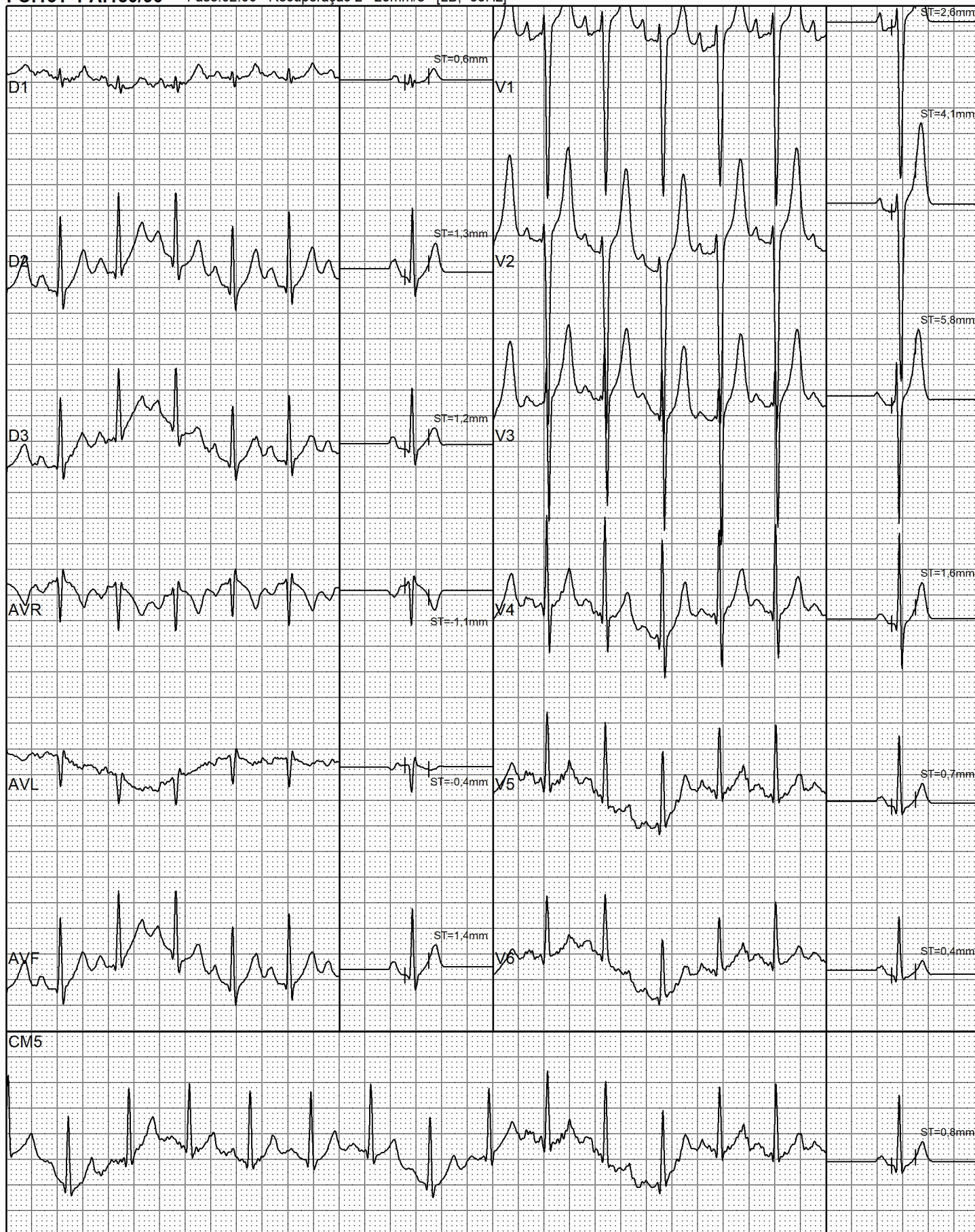


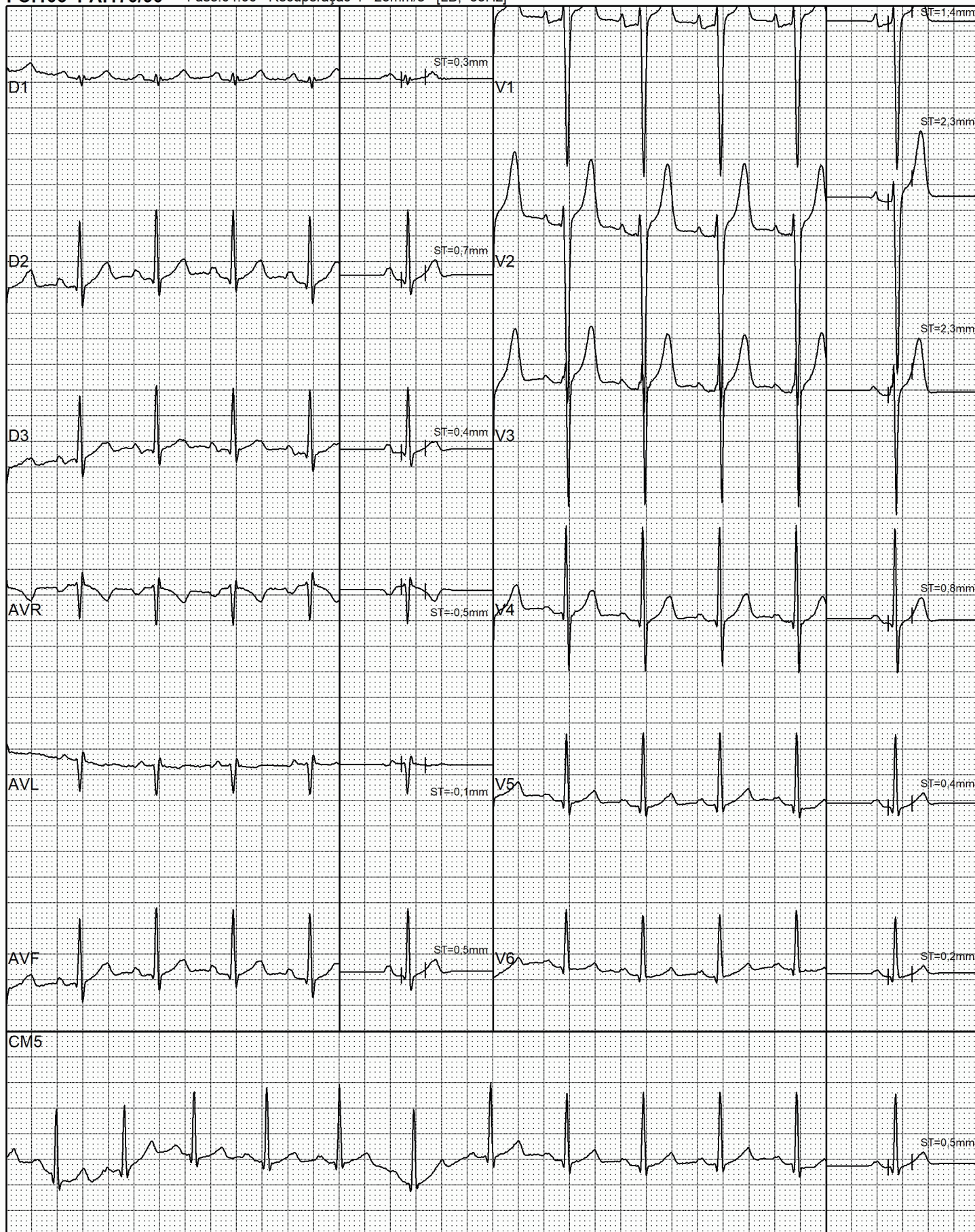


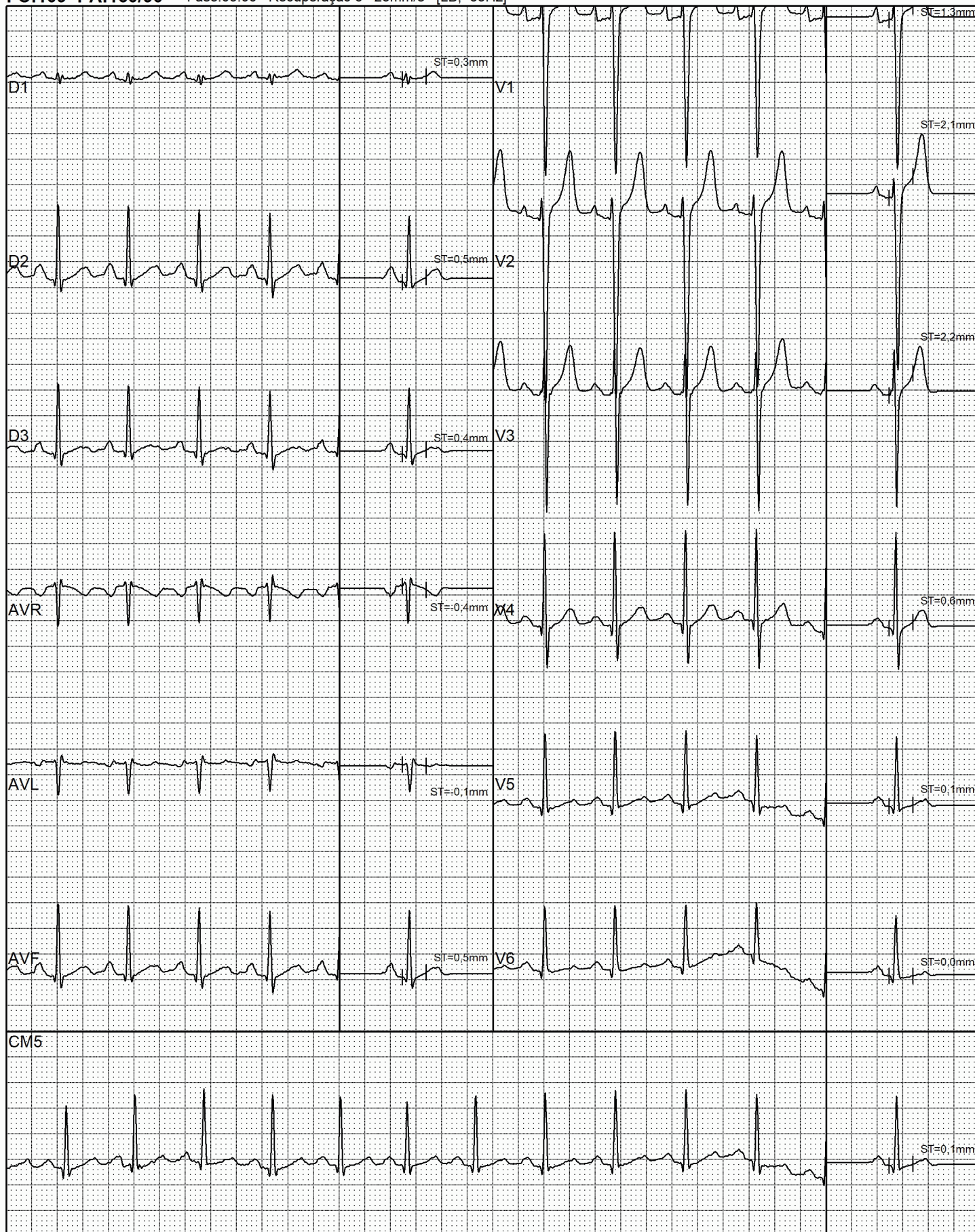


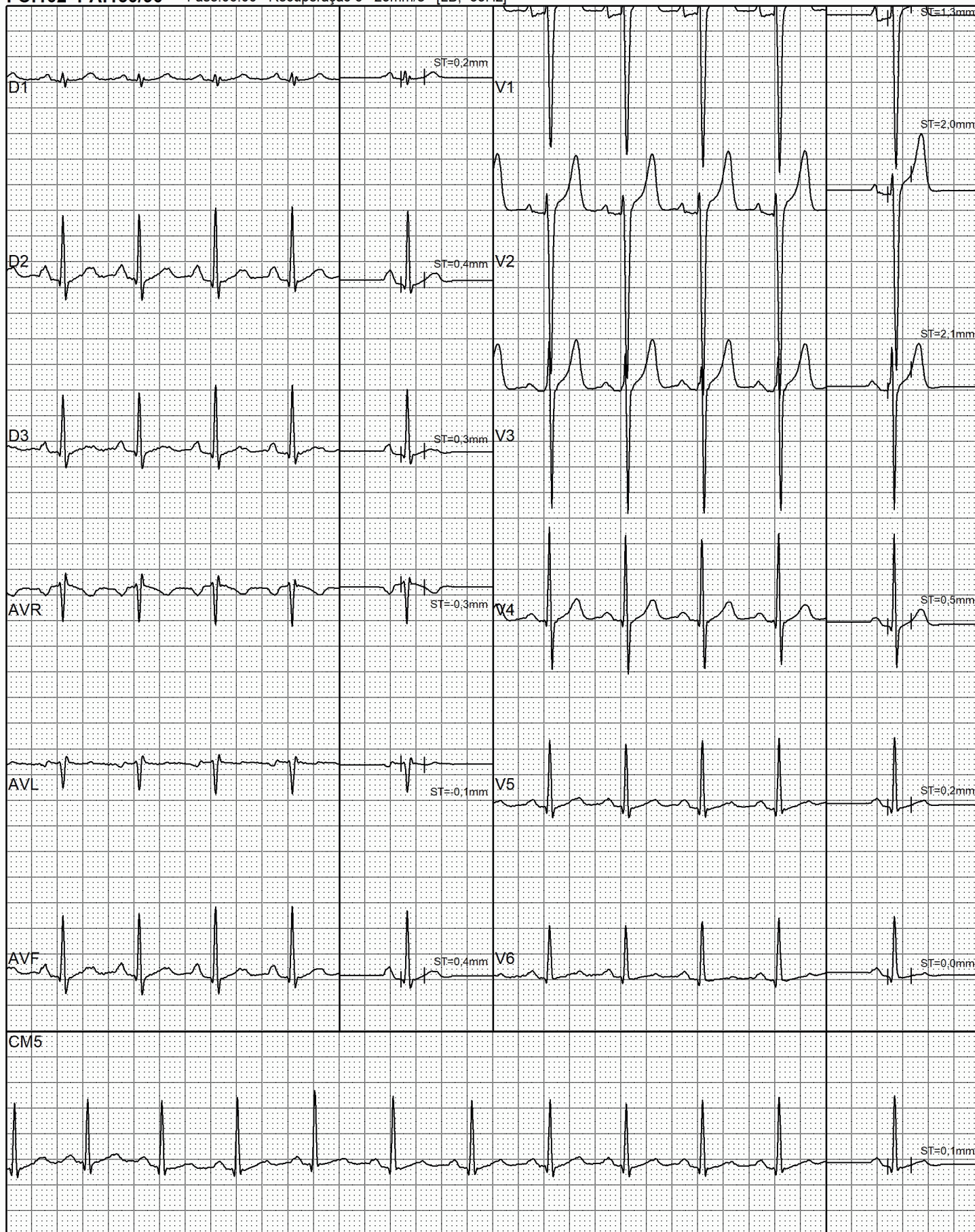










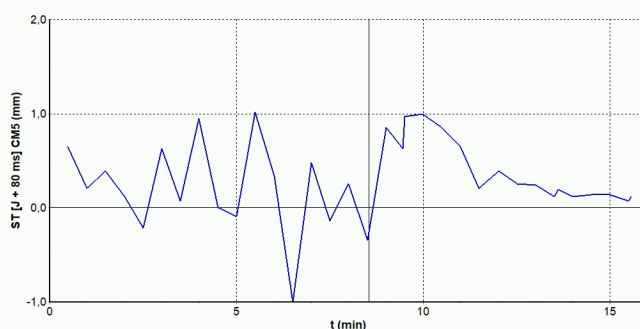
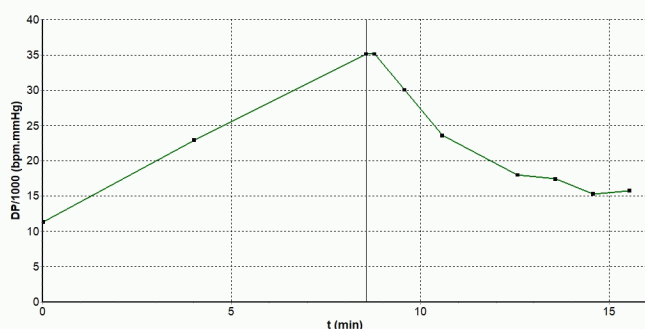
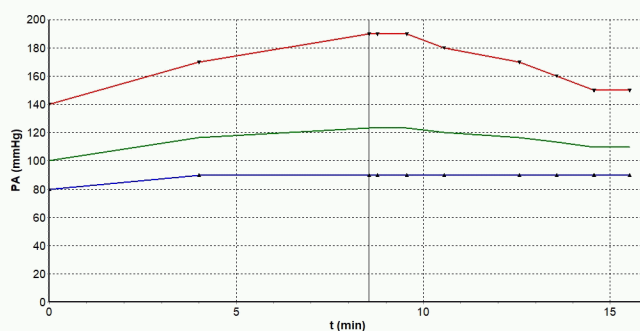
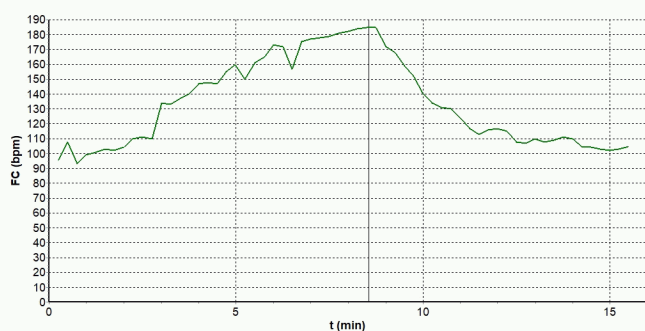




Resposta Cardiovascular ao Exercício

Paciente : pc06832 - GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

Exame : ex07530



- Freqüência cardíaca :

Sub-máxima prevista : 165 bpm Máxima prevista : 194 bpm Máxima atingida : 185 bpm (95% prev.) (Déficit cronotrópico 5%)
Recuperação : 1º Minuto : 159 bpm (Delta FC = -26 bpm) 2º Minuto : 131 bpm (Delta FC = -54 bpm)

- Pressão arterial :

Sistêmica de repouso : 140/80 mmHg (81 bpm)
Sistólica sob esforço : Máxima = 190 mmHg Pico do esforço = 190 mmHg
Delta PA = 50 mmHg Delta PA/MET = 3,4 mmHg/MET
Recuperação : 1º Minuto : 190/90 mmHg 2º Minuto : 180/90 mmHg

- Classificação funcional : I (segundo NYHA)

Aptidão Córdio-respiratória : Boa (segundo AHA)

VO₂ esf. máx. = 52,2 ml/(kg.min) VO₂ previsto = 50,7 ml/(kg.min) FAI = -3% MVO₂ = 42,9 ml/100gVE/min Ind. Cron. = 92,0 %
Distância percorrida : 1200 m

- Escore de Duke : 14

(Prognóstico de Risco: >= 5 - Baixo >= -10 e < 5 - Médio < -10 - Alto)

Tempo (min)	Estágio	FC (bpm)	PA (mmHg)	DP	MET
02:21	Deitado	81	140/80	11340	---
02:00	Rampa - 1,3 MET/min (5,6km/h 2,7%)	105			6,1
04:00	Rampa - 1,3 MET/min (8,1km/h 5,3%)	135	170/90	22950	8,7
06:01	Rampa - 1,3 MET/min (10,8km/h 8,0%)	173			11,8
08:01	Rampa - 1,3 MET/min (12,7km/h 10,0%)	183			14,5
08:33	Rampa - 1,3 MET/min (12,7km/h 11,1%)	185	190/90	35150	14,9
00:13	Recuperação 1	185	190/90	35150	---
01:00	Recuperação 1	158	190/90	30020	---
02:00	Recuperação 2	131	180/90	23580	---
04:00	Recuperação 4	106	170/90	18020	---
05:00	Recuperação 6	109	160/90	17440	---
06:00	Recuperação 6	102	150/90	15300	---
06:57	Recuperação 7	105	150/90	15750	---

Amil Espaço Saúde Nova Iguaçu

Rua Athaíde Pimenta de Moares, 408

Centro, Nova Iguaçu - RJ

TESTE ERGOMÉTRICO

Laudo

Paciente : pc06832 - GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

Data do Exm: 22/07/2025

Esforço interrompido aos 08:33 minutos [12,7km/h (8,0mph) 11,8%].

Motivos de interrupção do esforço

- Cansaço físico

Observações

- Comportamento fisiológico do segmento ST no esforço
- Comportamento fisiológico do segmento ST na recuperação
- Ausência de arritmias
- Resposta pressórica fisiológica
- Resposta cronotrópica fisiológica
- Nenhum sintoma clínico observado
- ECG Basal: Ritmo sinusal, dentro dos limites de normalidade.

Conclusões Finais

LAUDO DO TESTE ERGOMÉTRICO.

Paciente: GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

Teste de estresse físico realizado no protocolo de Rampa - 1,3 MET/min, utilizando a equação de Foster com apoio das mãos.

Teste interrompido por Cansaço físico; (Borg: 10/10), aos **08:33 min**

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Não houve registro de dor torácica ou manifestações clínicas sugestiva de isquemia miocárdica.

ANALISE DO ECG

ECG basal em ritmo sinusal sem distúrbios de repolarização ventricular

As alterações da repolarização ventricular ocorridas durante o teste foram consideradas fisiológicas, próprias do exercício.

DISTURBIO DO RITMO DE CONDUÇÃO

Durante o exame não visualizamos distúrbios do ritmo e/ou da condução atrioventricular ou intraventricular.

RESPOSTA CRONOTROPICA

Adequada mobilização da reserva cronotrópica ao esforço desenvolvido, avaliada através do índice cronotrópico: **92,0 %** (valor de referência >0,80).

Redução adequada da frequência cardíaca pós-esforço, avaliada no primeiro minuto da recuperação, inferindo-se satisfatório retorno da atividade autonômica parassimpática pós-exercício.

RESPOSTA HEMODINÂMICA

Variação normal da pressão arterial sistólica compatível com a intensidade de exercício realizado,

Continua...

Amil Espaço Saúde Nova Iguaçu

Rua Athaíde Pimenta de Moares, 408

Centro, Nova Iguaçu - RJ

TESTE ERGOMÉTRICO

Conclusões Finais (continuação)

com valores iniciais elevados. **3,4 mmHg/MET**

Resposta adequada de pressão arterial diastólica.

CONCLUSÕES

Teste ergométrico sem critérios eletrocardiográficos para o diagnóstico de isquemia miocárdica induzida pelo exercício.

Adequada mobilização da reserva cronotrópica ao esforço desenvolvido.

Adequada resposta autonômica na fase de recuperação pós-exercício.

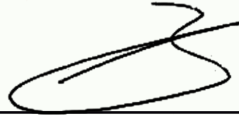
O exercício não provocou aparecimento de arritmias

Hipertensão arterial de repouso não reativa ao esforço

Parâmetros clínicos normais compatíveis com o esforço realizado.

A aptidão cardiorrespiratória foi considerada **Boa (segundo AHA)** baseada no consumo de oxigênio do pico do exercício, estimado pela equação de Foster em **52,2 ml/(kg.min) (103,0% previsto)**

*Este é um exame complementar e, como tal deverá ser analisado por seu médico assistente para correlação clínica e decisão terapêutica.



Dr. BRENO NOGUEIRA DA ROSA
CRM: 52787280